外科学骨科疾病

考频（10题，★★★）：A_1 3　A_2 5　B 0　X 2

①运动系统畸形

②运动系统损伤：骨折和脱位（四肢+躯干、概论）、膝关节损伤、慢性损伤（肩周炎等）

③颈腰椎退行性病

④骨与关节感染：化脓性、结核

⑤非化脓性关节炎：强直性脊柱炎、骨关节炎、~~类风湿关节炎~~

⑥骨肿瘤：骨软骨瘤、骨巨细胞瘤、骨肉瘤等

核心精讲

运动系统畸形

性感认识：转变思路提高效率

一、先天性肌性斜颈

外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
01:02:36--01:06:06

①一侧胸锁乳突肌挛缩→头偏向患侧、下颌转向健侧，患侧面部发育小

②<1岁：按摩、热敷、手法矫正、矫形帽外固定

③胸锁乳突肌切断术的最佳年龄：1-4岁

1岁后：

斜颈割脖：先天性肌性斜颈作胸锁乳突肌切断术的最佳年龄1-4岁

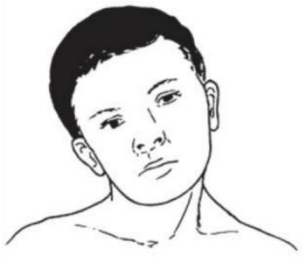
后催睾降蛋：隐睾治疗——1岁后短期用hCG等「催一催-h 后 c 催 g 睾」

单纯疝囊高位结扎：>1岁婴幼儿等「结扎大一窄」









二、发育性髋关节脱位

外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
01:06:06--01:23:39

①重要病因：原发性髋臼发育不良、关节韧带松弛症

②病理变化：分为站立前期和脱位期（站立行走期）。其中站立前期的病变有：髋臼发育不良、浅而平坦，关节囊和韧带松弛，股骨头较小、圆韧带肥厚、股骨颈前倾角增大、股骨头可在髋臼内或脱位（鞋-鞋带-脚）

③女性多见，左侧多见

④站立前期：大腿内侧皮肤皱褶患侧加深增多，会阴部增宽，患侧下肢短缩，牵拉患侧下肢有弹响，Ortolani弹入试验和Barlow弹出试验（3个月以上不宜进行），髋关节屈曲外展试验，Allis/Galeazzi征

⑤站立行走期：跛行、鸭行步态、Trendelenburg征/单足站立试验、股骨头上下移动似打气筒

TT欧巴外面去给三阿哥打气（T像单足站立、TT打气使你站立）

⑥超声筛查；出生3个月后X线（shenton线中断）

「理顺知识点」

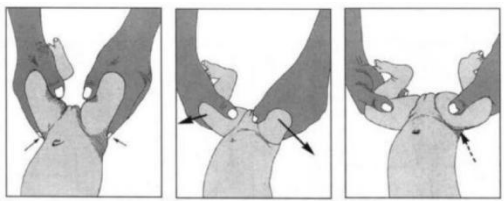
- 一般关节脱位往后上方脱；但是肩关节往前面脱
- 3个月后软骨骨化，此时进行Ortolani弹入试验和Barlow弹出试验可能造成骨骼损伤
- 发育性髋关节脱位分为站立前期（未独站或行走前）和脱位期（站立行走期），Trendelenburg征（单足站立试验）和打气筒征仅见于站立行走

「串联」

- Trendelenburg 试验：提示大隐静脉瓣膜功能不全

⑦治疗：

新生儿期（0-6个月-黄金时期）	Pavlik吊带维持髋关节屈曲外展（六味地黄丸、外面去拍拍）
婴儿期（6个月-1.5岁）	闭合复位固定于“人类位”
幼儿期（1.5岁-3岁）	切开复位
儿童期及以上（3岁以上）	切开复位，Salter骨盆截骨（1.5-6岁、髋臼指数＜45°、以前缘缺损为主）



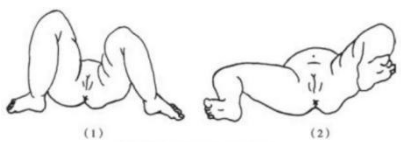


图 59-3　阳性体征及检查试验
（1）双下肢不等长，左大腿内侧皱褶增加，左臀部呈现凹陷状　（2）髋关节屈曲外展试验显示左侧阳性，右侧正常

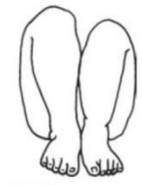


图 59-4　Allis 征左侧膝关节低于健侧（右）



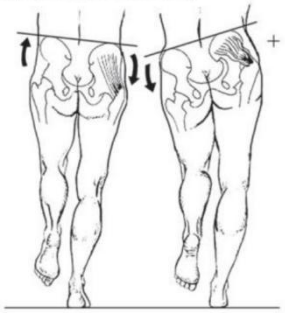
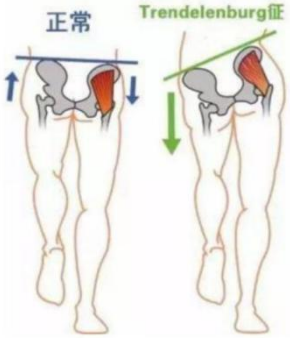


图 59-5　Trendelenburg 征（单足站立试验）



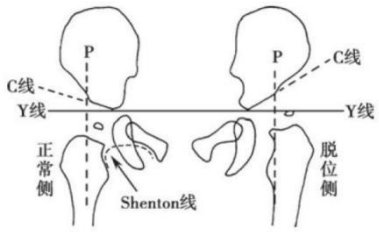


图 59-7　Perkin 象限、髋臼指数及 Shenton 线示意图


图 59-6　X 线平片示儿童发育性髋关节脱位（右侧）





图 59-8　Pavlik 吊带治疗发育性髋关节脱位

三、特发性脊柱侧凸

外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
01:23:39——01:26:49

①最常见的结构性脊柱侧凸

注意：非结构性脊柱侧凸是指脊柱及其支持组织无内在的固有改变，针对病因治疗后脊柱侧凸可消除。如神经根受刺激（腰椎间盘突出）、癔症、髋关节挛缩、姿势不当、下肢不等长、炎症（神医说知无不言）

②双肩不等高、胸廓不对称、剃刀背，可致慢性肺心病

③ Cobb角：＞10° 诊断、＜20° 观察随访、20–40° 支具（恐怖四肢两对）、＞40° 手术

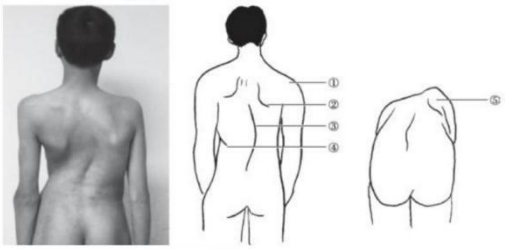


图 59-24　脊柱侧凸外观
①两肩不等高　②两侧肩胛骨不等高　③脊柱偏离中线　④一侧腰部皱褶皮纹　⑤前弯时两侧背部不对称，形成“剃刀背”





图 59-25　站立位脊柱全长正位 X 线片





真题解析·运动系统畸形

外科　泌外梗阻和外伤&运动系统畸形
01:27:31--01:37:52

1.2012N180X典型性先天性髋脱位的主要发病因素有

A.髋臼发育不良

B.股骨颈前倾角增大　　若问病理变化则全选

C.关节囊、韧带松驰

D.股骨头发育不良

2.2013N118-120A女性，13岁。1年前无意中发现双肩背部不等高，后逐渐明显。X线显示胸椎侧凸畸形，Cobb角25°,临床诊断为特发性脊柱侧凸。

118.对该患者的最佳治疗方案是

A.改变坐姿　　Cobb角：＞10°诊断、＜20°观察随访、20-40°支具、＞40°手术

B.立即手术治疗

C.牵引按摩治疗，每月随诊一次

D.佩戴支具，每半年随诊一次

119.其治疗目的是

A.找到病因，去除病因

B.尽早手术，矫正畸形

C.矫正畸形，获得稳定，维持平衡

D.维持目前状态，待骨骼成熟后再行手术治疗

120.以下关于该病的说法中，不正确的是

A.属于非结构性脊柱侧凸　　神医说知无不言

B.最常见，约占脊柱侧凸75%-80%

C.严重胸廓畸形可使肺受压变形，引起通气功能障碍

D.可分为婴儿型、少儿型、青少年型及成人型

3.2013N180X以下先天性肌性斜颈的临床表现中，错误的有

A.头向健侧偏斜

B.下颌向健侧偏斜

C.健侧脸部发育较大

D.患侧脸部发育较大

　答案：1-3 AC DCA AD

4.2019N164X下列属于非结构性脊柱侧凸的有

A.腰椎间盘突出合并脊柱侧凸

B.Marfan综合征合并脊柱侧凸

C.下肢不等长合并脊柱侧凸

D.姿势不正性脊柱侧凸

5.2021N65A站立前期先天性髋关节脱位的典型体征是

A.屈髋畸形

B.骨盆挤压试验(+)

C.弹入试验(Ortolani)(+)

D.摇摆式跛行

6.2022N106-107A男婴，20天。一天前洗澡时无意中被发现右颈部有一椭圆形肿物，局部无红肿热痛，头部轻度向右偏斜，下颌向右侧被动旋转活动受限，无发热及腹泻，偶有吐奶。

106.最可能的诊断是

A.颈部软组织炎症

B.先天性肌性斜颈

C.视力性斜颈

D.骨性斜颈

107.明确诊断后，对该婴儿应采取的治疗为

A.胸锁乳突肌切除术

B.给予肌松药物

C.胸锁乳突肌松解术

D.局部热敷、按摩

7.2022N165X属于非结构性脊柱侧凸的原因包括

A.姿势性脊柱侧凸

B.癔症性脊柱侧凸

C.神经根受刺激脊柱侧凸

D.先天性脊柱侧凸

　答案：4-7 ACD C BD ABC